

 RETINHER S.A.S

UCAD

Unidad Clínica de Alto Desempeño - Modelo EFQM

"Te Veo y Ves"

Programa de Prevención de Ceguera
en Pacientes Diabéticos

CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS

 **Vigencia**
2025 - 2028

 **Ubicación**
Córdoba, Colombia



¿Qué es UCAD "Te Veo y Ves"?



Prevención Estructurada

Programa preventivo basado en evidencia clínica para la detección temprana de retinopatía diabética, diseñado para reducir la incidencia de ceguera evitable.



Centrado en el Paciente

Modelo de atención integral y humanizado enfocado exclusivamente en las necesidades del paciente diabético y su contexto psicosocial.



Cobertura Regional

Enfoque territorial en el Departamento de Córdoba, buscando llegar a zonas urbanas y rurales dispersas con tecnología móvil.



Alineación Estratégica

Articulado con el Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE) y los estándares de acreditación en salud del modelo REDER.

Propósito y Visión



PROPÓSITO

Reducir la **pérdida de visión irreversible** en personas con diabetes, centralizando nuestro esfuerzo en el cuidado humanizado.

- Detección Proactiva
- Derivación Oportuna
- Mejora de Calidad de Vida



VISIÓN

AÑO 2028

Ser el **modelo referente a nivel regional**, donde la excelencia operativa asegura un futuro sin retinopatía diabética evitable.

- Liderazgo Regional
- Excelencia en Detección
- Futuro sin Ceguera Evitable

Objetivos Estratégicos



80%

Cobertura anual de tamizaje en población de riesgo identificada



90%

Seguimiento efectivo en la Red de Referencia Digital



80%

Estabilización clínica de retinopatía a los 12 meses



Líder

Excelencia en gestión del conocimiento e innovación regional



-10%

Reducción anual en el costo operativo por paciente tamizado

Valores Institucionales

Principios rectores que guían nuestra labor en la prevención de la ceguera y el cuidado integral del paciente diabético.



HUMANIZACIÓN

Atención cálida y empática centrada en la dignidad del paciente y su familia.



CALIDAD

Excelencia en procesos clínicos y seguridad basada en estándares superiores.



INNOVACIÓN

Adopción continua de tecnología y nuevos modelos de atención en salud.



TRABAJO EN EQUIPO

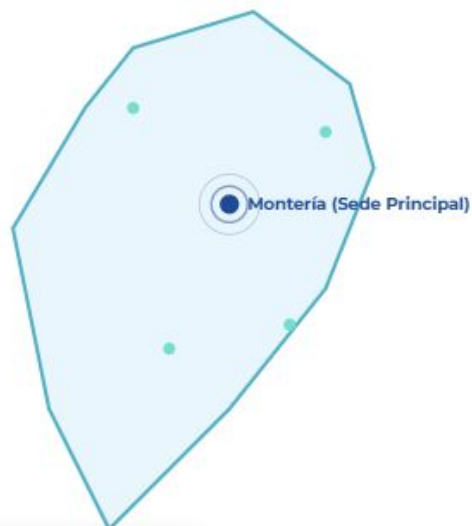
Sinergia multidisciplinaria para lograr resultados integrales de salud.



COMPROMISO SOCIAL

Responsabilidad con la salud visual de las comunidades más vulnerables.

Cobertura y Población Objetivo



Departamento de Córdoba

Zona de Influencia

Grupos de Interés Prioritarios



Pacientes Diabéticos

Todos los pacientes con diagnóstico confirmado de Diabetes Mellitus Tipo I y Tipo II.



Gestantes con Diabetes

Mujeres embarazadas con diabetes preexistente o gestacional (alto riesgo de progresión).



Sin Tamizaje Reciente

Pacientes diabéticos que no han tenido un examen de fondo de ojo en más de un año.

Organigrama Institucional



Dirección y Calidad



DIRECCIÓN GENERAL

Estrategia y Liderazgo

- ✓ Liderazgo de la **gestión estratégica** y toma de decisiones clave del programa.
- ✓ Gestión de **convenios y contratos** para la ejecución y sostenibilidad.
- ✓ Supervisión de **indicadores de impacto** (cobertura,



ASESOR SIG

Sistema Integrado de Gestión

- ✓ Garantizar la **calidad y seguridad del paciente** mediante auditorías internas.
- ✓ Diseño y actualización de **procesos, procedimientos y protocolos**.
- ✓ Gestión de riesgos y acciones de **mejora continua**.

Área Administrativa



COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Gestión Operativa

- ✓ Coordinación del talento humano y procesos administrativos.
- ✓ Gestión de recursos físicos, tecnológicos y logística.
- ✓ Apoyo en cumplimiento de metas de cobertura.



TRABAJO SOCIAL

Abordaje Psicosocial

- ✓ Gestión de barreras de acceso al programa.
- ✓ Orientación psicosocial al paciente y familia.
- ✓ Articulación con redes de apoyo comunitario.



ORIENTADOR DE PROGRAMA

Identificación Temprana

- ✓ Identificación temprana de pacientes diabéticos.
- ✓ Educación básica sobre cuidado visual y programa.
- ✓ Verificar que la identificación sea visible y correcta.
- ✓ Informar al equipo asistencial enfermería y diagnóstico sobre el paciente identificado como diabético.



ADMISIONISTA CLÍNICO

Registro y Agenda

- ✓ Registro e ingreso de pacientes al sistema.
- ✓ Gestión de agendas y citas especializadas.
- ✓ Informar al usuario sobre el proceso del programa.

Área Asistencial



DIRECTOR MÉDICO

Dirección Técnica

- ✓ Diseño y actualización de protocolos clínicos.
- ✓ Supervisión clínica y monitoreo de indicadores.
- ✓ Liderazgo en educación continua del personal.



ESPECIALISTAS

Oftalmología

- ✓ Diagnóstico y clasificación de Retinopatía Diabética.
- ✓ Definición de conducta clínica y remisiones.
- ✓ Interpretación de exámenes diagnósticos.



AUX. DIAGNÓSTICO

Apoyo Técnico

- ✓ Toma de retinografías de alta calidad.
- ✓ Aplicación de protocolos de atención.
- ✓ Garantizar calidad de imagen diagnóstica.
- ✓ Registrar información técnica del examen.



ENFERMERA P&P

Promoción y Prevención

- ✓ Educación en autocuidado y control glicémico.
- ✓ Seguimiento a pacientes diagnosticados.
- ✓ Registro en aplicativo y entrega de reportes.

Procedimiento de Tamizaje

Flujo de atención integral para la detección temprana de Retinopatía Diabética



Modelo One-Stop Shop

El flujo está diseñado para realizarse en un solo momento de atención siempre que sea posible.

Clasificación del Riesgo Visual

ESTADO	DIAGNÓSTICO	NIVEL RIESGO	ACCIÓN
	Sin Retinopatía	BAJO RIESGO	Control anual
	RD Leve	RIESGO LEVE	Control 6-12 meses
	RD Moderada	RIESGO MODERADO	Control 6 meses Optimizar metas
	RD Severa	ALTO RIESGO	Referencia Urgente Especialista
	RD Proliferativa	MUY ALTO RIESGO	Tratamiento Inmediato (Láser/Cx)
	Edema Macular	RIESGO VISIÓN	Referencia Prioritaria Retina

Factores de Riesgo



Duración Diabetes

A mayor tiempo, mayor riesgo



Control Glucémico

HbA1c elevada y fluctuante



Hipertensión (HTA)

Daño vascular adicional



Dislipidemia

Colesterol y triglicéridos altos



Embarazo

Riesgo de progresión rápida

Rutas de Atención por Clasificación



RETINA NORMAL

Sin Retinopatía



Seguimiento
Trimestral (Enfermería)



Tamizaje Anual
Control en UCAD



Manejo Interno
Programa UCAD



RD LEVE / MODERADA

Riesgo Intermedio



Tamizaje 6 Meses
+ Seguimiento Enfermería



Referencia IPS
Control Metabólico



Notificación EAPB
Gestión del Riesgo



RD SEVERA / EMD

RD Proliferativa / Edema



REFERENCIA INMEDIATA
Prioridad Alta



Especialista Retina
Láser / Inyecciones / Cx



Notificación URGENTE
EAPB y Aseguradora

Indicadores de Éxito



COBERTURA TAMIZAJE



SEGUIMIENTO



ESTABILIZACIÓN



SATISFACCIÓN DEL PACIENTE

Basado en encuestas trimestrales



OPORTUNIDAD REMISIÓN

≤ 7

DÍAS HÁBILES

Meta Alta Prioridad